Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Elvis Esteler Silva Tapia					Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	06-11-2016	Edad actual	8 años	4 meses	País natal:	Chile		
Domicilio actual:	Pasj. Las Araucarias, Las Golondrinas				Teléfono	967333292		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ~~☐~~ habla ~~☐~~ lee ☐ escribe ☐					
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ~~☐~~ habla ~~☐~~ lee ☐ escribe ☐					
Escolaridad actual:	Tercer "A"	Establecimiento	Liceo Mixto Básico N°2					

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 25/03/2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Zinnia Tapia Ibaceta	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista: 25/03/2025	4. Fecha de la entrevista:
Nombre: Catherine Estay Murúa	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista:	2. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Ingreso al Programa de Integración Escolar, Cambio de Diagnóstico de Déficit Atencional con Hiperactividad a Trastorno del Espectro Autista.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí (especificar)

Pediatría: X	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☒ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO | Peso: 3.75 kg | Talla: 50 cm.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

Sin Antecedente Relevante

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Si	☒ No	Traumatismos	Si	☒ No	Encefalitis	Si	☒ No
Obesidad	Si	☒ No	Intoxicación	Si	☒ No	Meningitis	Si	☒ No
Fiebre alta	Si	☒ No	Enfermedad respiratoria	Si	☒ No	Otra(s)		
Convulsiones	Si	☒ No	Asma	Si	☒ No			
Hospitalizaciones	Si	☒ No	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	☒ Si	No		Vacunas	☒ Si No

Observaciones:

Sin Observaciones.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 6 meses	Se sienta sólo/a: 7 meses	Camina sin apoyo: 1 año
Primeras palabras: 11 meses	Primeras frases: 1a y 2m.	Se viste solo/a: 6 años.
Controla esfínter vesical Diurno: 1a Nocturno: 1a	Controla esfínter anal Diurno: _____ Nocturno: _____	

Observaciones:

Sin Observaciones.

En su actividad motora general se aprecia:

☐ normal ☐ activo ☒ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:

☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	☒ Si	No	Caídas frecuentes	Si	☒ No	Dominancia lateral	☒ Si	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	☒ Si	No	Prensión	☒ Si	No	Pinza	☒ Si	No
Ensarta	☒ Si	No	Dibuja	☒ Si	No	Escribe	☒ Si	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	☒ Si	No	Manipula y Explora objetos	☒ Si	No
Demanda objetos y compañía	☒ Si	No	Comprende prohibiciones	Si	☒ No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	☒ Si	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	☒ Si	No

Observaciones:

Luis tiene cambio de diagnóstico.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones:

Debe asistir a control oftamologico.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): No

Observaciones:

Sin Observaciones.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	Sonidos:	Personas extrañas:
☒ natural ☐ desmesurada	☐ natural ☒ desmesurada	☒ natural ☐ desmesurada

Observaciones:

Se le dificulta seguir Normas dentro y fuera del aula.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al dia	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad Infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

Se encuentra en tratamiento Salud Mental.

Alimentación: ☒ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☒ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☒ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 10 Horas

☒ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☐ acompañado
(Especifique):

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☒ alegre ☐ juguetón/bromista ☒ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☒ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro:

Observaciones:

Elvis presenta cambios muy repentinos de humor, estado de ánimo, se irrite con facilidad.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Guillermo Silva E.	Padre	81	E.B.I	Comerciante
2. Zinnia Tapia I	Madre	51	E.M.C.	Dueña de casa
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Padre hipertenso, arritmia cardiaca.
Madre presenta problemas de Salud Mental.
Mantiene Controles mensuales.

Observaciones:

Padre tiene operación al corazón en dos oportunidades.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	Nº 2M.	Asistió a jardín infantil	Sí ✓	No
Nº de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza Regular ☐ ✓ Especial ☐ Técnica ☐:		

Motivo de los cambios:
Por Discriminación y etiqueta al estudiante.

Ha repetido curso/s	Sí	No ✓	Curso(s) /	Motivo: —

Situación actual

Nivel/curso actual	3er A		Dificultad de aprendizaje	Sí	No ✓	Dificultad para participar	Sí ✓	No	Conducta disruptiva	Sí ✓	No
Asiste regularmente	Sí ✓	No	Asiste con agrado	Sí ✓	No	Apoyo familiar en tareas	Sí ✓	No	Amigos (as)	Sí ✓	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?

☐ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?

☒ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?

☒ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....

Especifique el tipo de refuerzos o premios:

☐ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?

☐ madre ☒ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?

☐ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?

☐ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Se encuentra con medicamentos Dispersidone (Risnia) dos tabletas por la mañana.
Metilfenidato dos tabletas por la mañana
Centro Médico Salud Mental Infanti!
(CETAM PARRUDO)
Elvis debe volver al tratamiento con
Psicólogo del CETAM.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY